## 内科学含诊断学 消化系统疾病

**考频（7-12 题，★★★）：$A_1$ 3-4　　$A_2$ 3-6　　B 0-2　　X 1**

①胃食管反流病、胃炎、消化性溃疡（内科+外科）和消化道出血（内科+外科）
②肠结核和结核性腹膜炎、炎症性肠病、肠易激综合征
③肝性脑病、原发性肝癌（内科+外科）、肝硬化
④胰腺炎（内科+外科）

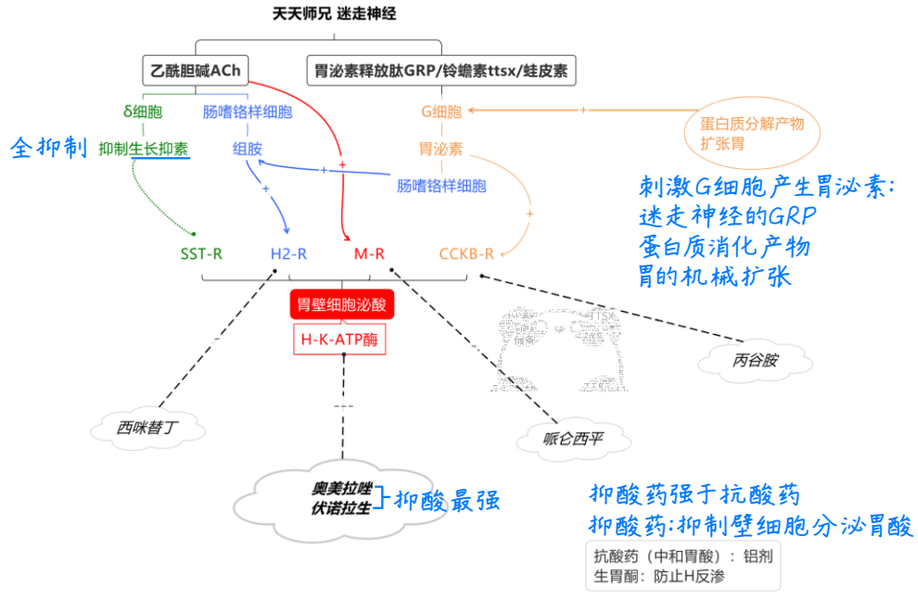
注意：先复习《病理学》消化系统疾病相关章节，再复习内科学，并回顾式串联《生理学》

## 核心精讲·胃食管反流病

（性感认识：反复反流烧心）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

复习《生理学》：




迷走神经肽能纤维：
1、促进G细胞释放胃泌素:胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素
2、食物经过时LES舒张:VIP+NO
3、胃容受性舒张:VIP+NO

食管下括约肌LES
（最重要的抗反流屏障）

- LES不存在明显解剖结构（LES没有平滑肌明显增厚）
- LES是平滑肌形成的高压区
- 食物经过时LES舒张（迷走神经释放VIP+NO）
- 食物入胃后LES收缩（迷走神经释放ACh）
- 胃泌素、胃动素、ACh等→LES收缩→压力增高→抗反流　记少不记多

### 一、胃食管反流病（gastroesophageal reflux disease,GERD）概述

胃肠中的内容物（胃酸、胃蛋白酶、非结合胆盐、胰酶）反流入食管及食管外组织，根据是否引起食管黏膜糜烂、溃疡，GERD 分为**反流性食管炎**（reflux esophagitis,**RE**）和**非糜烂性反流病**（nonerosive reflux disease,**NERD**）　酸雾:反流物形成的,可以反流到食管外组织

① 理顺非糜烂性反流病:
胃肠内容物(包括胃酸、胃蛋白酶、非结合胆盐、胰酶)反流入食管和食管外的组织时,若造成的损伤较轻微,可不形成糜烂、溃疡,称为非糜烂性反流病。
即胃镜检查正常时,不可排除诊断胃食管反流病GERD。

## 二、病因

② 1.抗反流屏障——以 **LES** 结构和/或功能障碍、尤其功能障碍最重要

**食管裂孔疝**、贲门失弛缓症**术后** VS 贲门失弛缓症是LES痉挛,不会反流

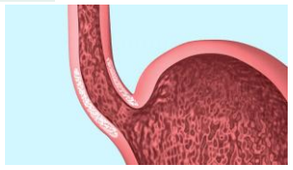
胃内压增高（胃排空延迟、胃扩张等）、腹内压增高（便秘、肥胖、妊娠、腹水等）

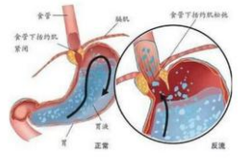
高脂食物、巧克力 排空↓→胃内压↑　　排空速度:糖>蛋白质>脂肪

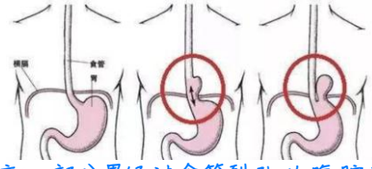
胰高血糖素、促胰液素、缩胆囊素 CCK、前列腺素、血管活性肠肽 VIP 下位抑制上位→抑制胃排空→胃内压↑

钙拮抗剂 CCB、地西泮、硝酸甘油、抗胆碱药等　松弛消化道平滑肌

（记少不记多：平滑肌舒张 **胃泌素、胃动素、ACh、治疗 GERD 药物不会导致 LES 压力降低** 镇静松弛 平滑肌舒张）

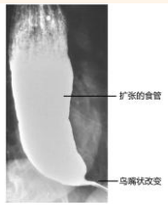


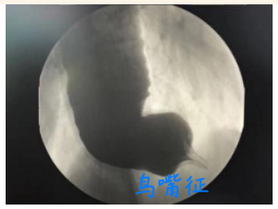




食管裂孔疝:一部分胃经过食管裂孔从腹腔进入胸腔

《外科学》：食管贲门失弛缓症是食管下 2/3 部的肌间神经丛受损→食管下括约肌不能松弛→吞咽困难、钡餐呈鸟嘴样狭窄→行食管下段贲门肌层切开 Heller 术治疗→在贲门失弛缓症术后可因 LES 破坏发生胃食管反流病






③

2.食管清除作用降低：食管蠕动能力下降（如**食管裂孔疝**）、**干燥综合征** 口干(唾液减少)→不能冲洗/稀释反流物

既会影响抗反流屏障,又会使食管清除作用降低

3.食管黏膜屏障功能降低：长期饮酒、吸烟、刺激性食物或药物（NSAIDs）等

## 三、由反流物引起的临床表现

1.食管和食管外症状

（1）**食管**症状　④

①最常见典型症状：反流(反酸)、**烧心**（胸骨后剑突下烧灼感）本质是烧食管,内脏痛定位不准确

②因反流物刺激食管痉挛引起：**胸痛**（多为刺痛）、**吞咽困难**（多为间歇性）、**胸骨后异物感**

（2）**食管外**症状

①牙蚀症 酸雾造成牙齿的侵蚀溶解

②咽喉炎、癔球症（患者感到咽部不适，有异物感、堵塞感，但又没有真正的吞咽困难）

③声嘶 累及声带

④慢性咳嗽、非季节性哮喘、吸入性肺炎、肺间质纤维化

反流物刺激呼吸道 VS 支气管接触到了过敏原(花粉)→发作加重,有季节性

2.胃食管反流病**酷似心绞痛**

①共性：纵隔胸痛，均可向颈部、上肢、上腹部等放射 放射痛没有特异性

②区别：胃食管反流病的疼痛与体位改变有明显关系；心绞痛多为绞痛，休息或硝酸甘油有可能缓解，心电图多有异常　卧位、弯腰、腹内压升高时加重,站立、坐位时减轻

VS心绞痛:躺下休息疼痛可能缓解



② 理顺知识点:

抗反流屏障主要是由食管下括约肌(LES)、膈肌脚(由骨骼肌组成,环绕在食管裂孔周围)、His角(食管与胃底间的锐角)以及膈食管韧带等结构共同组成。但以LES结构和/或功能障碍,尤其是功能障碍最重要。

值得注意的是:

①.注意是贲门失弛缓症术后,贲门失弛缓症是食管下2/3部的肌间神经丛受损,导致食管下括约肌LES痉挛(不能松弛),不存在反流,此时出现间歇性吞咽困难的症状,钡餐下呈现鸟嘴样狭窄。

故对贲门失弛缓症的治疗措施为食管下段贲门肌层切开Heller术,但因术后肌层切开(LES破坏),即抗反流屏障损坏,出现胃食管反流病GERD。

②.食物对胃排空速度的影响中,即糖>蛋白质>脂肪,故高脂食物(包括巧克力),抑制胃排空,胃内难以消化,使胃内压增高,"顶着"食管下括约肌LES,促使其舒张,出现胃食管反流病GERD。

③.激素可分类记忆,胰高血糖素、促胰液素、缩胆囊素、前列腺素、血管活性肠肽都是下位激素,抑制胃排空,使胃内压增高,同样促进食管下括约肌LES舒张,促使其发生胃食管反流病GERD。

④.钙拮抗剂、地西泮、硝酸甘油、抗胆碱药等等,都能扩张平滑肌,使LES舒张(食管下括约肌并不是真正的括约肌,只是由平滑肌形成的高压区),出现胃食管反流。

③ 理顺分类:

注意胃食管反流病GERD病因的大分类为抗反流屏障障碍、食管清除作用降低、食管黏膜屏障功能降低。

而食管裂孔疝,既属于抗反流屏障受损,也可影响到食管下段蠕动,导致食管清除作用降低。

④ 理顺食管症状:

①.最常见的典型症状为反流(反酸)、烧心。因食管位于纵隔内,因胃肠中的内容物(胃酸、胃蛋白酶、非结合胆盐、胰酶)反流入食管及食管外组织,刺激内脏神经,而内脏痛定位是不准确的,因此描述为"烧心",本质上是"烧食管"。

②.胃肠中的内容物反流入食管后,刺激食管痉挛,导致平滑肌痉挛导致胸痛,故多为刺痛。而因食管平滑肌痉挛是间歇性的,故吞咽困难也呈现间歇性。

## 四、并发症（上下班）

1.上消化道出血：呕血、黑便、肠鸣音↑
铁与硫化氢形成硫化亚铁

规律：
肠道里面刺激肠管→肠鸣音↑
肠道外面刺激肠管→肠鸣音↓

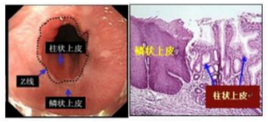
2.食管狭窄：除极少数严重瘢痕狭窄需手术治疗外，绝大部分狭窄可行内镜下食管扩张术
反流损伤→肉芽组织对损伤的食管黏膜进行纤维性修复

3.**Barrett 食管**

①食管下部的鳞状上皮被柱状上皮取代（**腺上皮化生**）食管鳞癌不是化生,食管腺癌与化生有关

②食管腺癌的癌前病变：需定期接受**胃镜随访**

《病理学》：化生是一种分化成熟的细胞组织转变为另一种形态功能不同的细胞组织，通常只出现在分裂增殖能力较活跃的细胞类型中，通过正常组织的干细胞等转分化实现







⑥ 更红,因为食管下部鳞状上皮被柱状上皮(薄)取代,血管透见

## 五、食管反流监测如电阻抗-pH 监测是诊断胃食管反流病的金标准（明确过度酸碱反流）

可能可能最可能：**反复反流、烧心**，多在**餐后** 1 小时、**卧位**、弯腰加重，站立、坐位减轻，考虑胃食管反流病：

①非糜烂性反流病：**NERD 胃镜食管**表现为**阴**性、**食管反流监测**提示存在反流的客观证据、质子泵抑制剂 PPI 试验性治疗有效 ttsx 看食管黏膜破损情况

②反流性食管炎：**胃镜**是诊断 **RE** 最准确的方法，洛杉矶 LA 分级（我气我）：

| | |
|---|---|
| A 级 | 食管黏膜有破损，其长径＜5mm |
| B 级 | 食管黏膜有破损，至少有一处长径＞5mm |
| C 级 | 食管黏膜有破损，且破损有**融合**、＜75%的食管周径 |
| D 级 | 食管黏膜有破损，且破损有**融合**、＞75%的食管周径 |

## 六、治疗

1.**抑酸药**

（1）**首选**、**最佳**：**质子泵抑制剂 PPI**（奥美/泮托**拉唑**）：与 $H^+$-$K^+$-ATP 酶不可逆结合，疗程 4-8 周（酸死吧）

伏特加

（2）**钾离子竞争性酸阻滞剂**（potassium-competitive acid blockers,**P-CAB**）：疗程 4-8 周，**伏诺拉生**与 $K^+$竞争结合 $H^+$-$K^+$-ATP 酶，酸环境稳定、不需酸激活、起效快、持续时间长、夜间作用确切、用药个体差异小和不良反应少

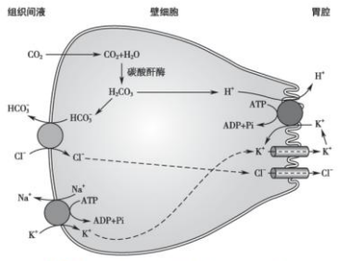



图 6-5　胃黏膜壁细胞分泌盐酸的基本过程模式图
$CO_2$ 与水分子结合形成碳酸，碳酸可解离为 $H^+$ 和 $HCO_3^-$，$H^+$ 通过 $H^+$,$K^+$-ATP 酶主动转运至分泌小管腔。

（3）**$H_2$-R 拮抗剂**（法莫/西咪**替丁**）：适合轻、中度患者，疗程 8-12 周（爸盯幺儿）

效应没有PPI/P-CAB强→疗程相对较长

⑤ 理顺并发症：
胃食管反流病GERD的并发症只有上消化道出血、食管狭窄、Barrett食管这三个。
常见干扰为食管穿孔,因胃肠中内容物反流入食管或食管外组织的位置不固定,不易在某一个位置侵袭形成穿孔。(用知识点做题,不要随意推理)

值得注意的是,上消化道是指从口腔到十二指肠的消化道部分,包括口腔、食管、胃和十二指肠,即十二指肠悬韧带(Treitz韧带)为标志,该韧带以下称为下消化道。
而上消化道出血后,红细胞中的血红蛋白(含有亚铁离子),与消化道中存在的硫化氢,形成硫化亚铁,因呈现黑色,称为黑便(为上消化道出血后的结果)。

⑥ 理顺辅助检查：
①.胃食管反流病GERD的金标准是食管反流监测(包括食管pH监测和食管阻抗-pH监测),如胃肠中反流的内容物一般为反酸,可通过测定pH值进行食管反流监测,可提供反流的客观证据,是诊断GERD的"金标准"。
(相较于胃镜,若为胃食管反流病的早期阶段或非糜烂性反流病NERD,只有反流而无糜烂、溃疡时,食管反流监测为更优选择)

②.胃镜是诊断反流性食管炎RE最准确的方法,可以直接观察到食管黏膜破损情况,并能判断其严重程度和有无并发症。
即怀疑胃食管反流病时,可先做食管反流监测以提供反流的客观证据,随后于内镜下观察到糜烂、溃疡,可直接诊断为反流性食管炎RE;
若胃镜下未见糜烂、溃疡,且质子泵抑制剂PPI试验性治疗有效,可诊断为非糜烂性反流病NERD。

长期维持治疗：　　损伤重→参与修复的肉芽组织多→产生的纤维瘢痕多→瘢痕收缩→食管狭窄

①停药后症状很快复发且持续、重度食管炎（LA-C 和 D 级）、食管狭窄、Barrett 食管（下班负重）
破损有融合　　癌前病变

②抑酸药中首选 PPI

2.弱碱性抗酸药（铝碳酸镁、磷酸铝、硫糖铝、氢氧化铝）：适合轻度患者临时缓解症状
中和胃酸

3.促胃肠动力药（莫沙必利莫刹车）：适合抑酸治疗后疼痛缓解而仍有腹胀的轻度患者
可促进上、下消化道运动→胃肠道压力↓→反流↓　VS　促胃动力药:(吗丁啉/多潘立酮):仅促进上消化道运动

4.腹腔镜胃底折叠术

## 真题解析·胃食管反流病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N66 A 诊断胃食管反流病，最准确的检查方法是
A.食管吞钡 X 线检查
B.食管测压
C.24 小时食管 pH 监测 金标准
D.胃镜检查

2. 2017N79-81 A 男性，54 岁，近 2 个月来反酸，烧心，多于餐后出现，平卧位时明显，5 天来情况严重，有时伴有胸骨后疼痛，ECG 检查未见明显异常，胃镜检查可见食管黏膜破损融合。LA-C级或D级
79.该患者最可能的诊断是 这里的胸骨后疼痛是刺痛,区别于心绞痛的绞痛
A.胃食管反流病
B.食管憩室炎
C.心绞痛
D.食管癌
80.该患者最佳的治疗方法是
A.氢氧化铝
B.硝酸甘油
C.奥美拉唑
D.尽早手术
81.若维持治疗，选用的最佳药物为
A.雷尼替丁　　下班负重→维持治疗
B.奥美拉唑
C.硝酸异山梨酯
D.顺铂和 5-氟尿嘧啶

题目:胃镜下没有看到食管黏膜破损不能排除胃食管反流病,因为有两个类型(RE和NERD)。先做食管反流检测→明确是否存在反流的客观证据→结合PPI试验性治疗有效→诊断NERD

3. 2019N50 A 下列引起胃食管反流病的病因中，不属于抗反流屏障结构与功能异常的是
A.胃扩张 胃压力高,抵着LES
B.贲门失弛缓症手术后 破坏LES
C.大量腹水 抵着LES
D.干燥综合征 食管清除作用↓

答案:1-3 C ACB D

4.2020N50 A 胃食管反流病的食管外症状是
A.烧心 本质是烧食管
B.咳嗽
C.胸痛 刺激到食管
D.吞咽困难

5. 2021N49 A 不属于胃食管反流病并发症的是
A.上消化道出血　　上下班
B.食管狭窄
C.食管憩室
D.Barrett 食管

6. 2022N50 A 以下属于胃食管反流病并发症的是
A.食管癌　　上下班
B.Barrett 食管
C.食管憩室炎
D.Mallory-Weiss 综合征

食管贲门黏膜撕裂/Mallory-Weiss 综合征：剧烈呕吐、之后呕出鲜血（位置高）VS 出血混有胃液:咖啡样血

7. 2023N49 A 女性，38 岁。反复反酸、烧心 5 年，平卧位时更明显，1 个月来加重，影响睡眠。首选的治疗药物是
A.硫糖铝
B.奥美拉唑
C.法莫替丁
D.多潘立酮

8. 2025N50 A 女性，42 岁。反复反酸、烧心 10 余年，平卧位时明显，近 2 个月来加重并影响睡眠，最适宜的治疗药物是
A.促胃肠动力剂
B.抗酸剂
C.质子泵抑制剂
D.组胺 $H_2$ 受体拮抗剂

**思维导图·胃食管反流病**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心




答案:4-8 B C B B C